



Nuansa
Fajar
Cemerlang

DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN IBU MENJALANI PROSES PERSALINAN

Ira Sukyati • Merida Simandjuntak
IGA Dewi Purnamawati

DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN IBU MENJALANI PROSES PERSALINAN

Ns. Ira Sukyati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Ns. Merida Simandjuntak, M.Kep., Sp.Mat.

Ns. IGA Dewi Purnamawati, M.Kep., Sp.Kep.An.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Dukungan Sosial Dalam Meningkatkan Kepuasan Ibu Menjalani Proses Persalinan

Penulis: Ns. Ira Sukyati, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Ns. Merida Simandjuntak, M.Kep., Sp.Mat.
Ns. IGA Dewi Purnamawati, M.Kep., Sp.Kep.An.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7097-84-2

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Prakata

Dalam perjalanan menuju kehamilan dan persalinan, setiap ibu mengalami berbagai emosi dan tantangan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan ibu selama proses bersalin adalah dukungan sosial. Buku ini hadir untuk membahas secara mendalam bagaimana dukungan sosial dapat meningkatkan kepuasan ibu saat proses bersalin.

Dengan memadukan teori dan praktik, serta pengalaman nyata dari para ibu, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dukungan sosial dalam meningkatkan kualitas pengalaman bersalin. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan ibu selama proses bersalin.

(Desember, 2024)

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv

Bab 1 Pendahuluan	1
--------------------------------	----------

Bab 2 Pemahaman tentang Kepuasan Ibu menjalani Proses Persalinan	5
A. Pengertian Proses Persalinan	5
B. Kepuasan Ibu Menjalani Proses Persalinan.....	19
C. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Ibu Bersalin.....	21

Bab 3 Dukungan Sosial dalam Meningkatkan Kepuasan Ibu Menjalani Proses Persalinan	29
A. Pengertian Dukungan Sosial	29
B. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial	30
C. Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Proses Bersalin.....	31
D. Beberapa Aspek Dukungan Sosial.....	32
D. Sumber Dukungan Sosial.....	36
E. Bentuk Dukungan Sosial	38
F. Komponen Dukungan Sosial.....	39

Bab 4 Strategi dan Intervensi untuk Meningkatkan Kepuasan Ibu Bersalin termasuk Cara Mendapatkannya.....	40
A. Peran Pendamping Persalinan	40
B. Kemampuan yang Harus dikembangkan	41
C. Kemampuan yang Harus Dipelajari	42
D. Dukungan dan Perawatan Selama Persalinan dan Kelahiran.....	42

E. Tingkatkan Perawatan Diri	44
F. Berbicara dengan Ibu yang Menjalani Persalinan	46
G. Pengembangan Layanan Kesehatan	46
H. Inovasi dalam Pengembangan Layanan Kesehatan	48
Bab 5 Penutup	50
 Daftar Pustaka	 53
Profil Penulis.....	59

Bab 1

Pendahuluan

Menurut WHO (2020) Angka kematian ibu masih sangat tinggi sekitar 94% berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah dan penyebabnya yaitu perdarahan 27,1%, gangguan hipertensi 14,0% dan sepsis 10,7 % dari semua kematian ibu. Menurut UNICEF (2017), Tindakan pencegahan untuk mengurangi angka kematian ibu bisa ditangani jika persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil seperti dokter, perawat atau bidan yang dilakukan monitoring secara teratur dalam hal memberikan tindakan yang tepat dan menyediakan peralatan yang lengkap dan sesuai kebutuhan.

Masa kehamilan dan persalinan merupakan pengalaman penting dalam kehidupan seorang Wanita dan pasangannya, pada masa ini, ibu mengalami banyak perubahan emosional (merasa Lelah, rasa sakit, ketidaknyamanan yang disebabkan oleh trauma pascapersalinan), hal ini bukanlah tugas yang mudah bagi seorang ibu. (Gebuze et al., 2016). Pada masa persalinan perubahan psikologis ibu mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu timbulnya rasa cemas dalam menjalani persalinan (Maharani, 2014). Hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan ibu dalam menjalani proses persalinan. Rasa Kepuasan terhadap layanan perawatan

persalinan merupakan sarana pencegahan sekunder kematian ibu, karena perempuan yang merasa puas cenderung akan lebih mematuhi anjuran penyedia layanan kesehatan. Pengalaman melahirkan yang positif dan sikap yang baik terhadap peran sebagai ibu akan meningkatkan kepuasan Wanita terhadap perawatan yang diberikan selama persalinan dan melahirkan, yang memfasilitasi transisi positif ke peran sebagai ibu.

Pengalaman melahirkan yang negative dapat menyebabkan wanita merasa putus asa dan membahayakan kesehatan mentalnya, yang meningkatkan risiko postpartum blues, depresi, gangguan psikotik dan gangguan stress pascatrauma (Kidane, 2022). Kepuasan ibu dengan perawatan intrapartum terkait erat dengan pemanfaatan layanan dan persepsi hasil perawatan yang memenuhi harapan. Ibu yang mengalami ketidakpuasan terhadap persalinan yang dijalannya, memberikan dampak yang cukup serius yaitu rasa tidak bahagia, dan ibu akan mempersepsikan persalinan yang tidak memuaskan sebagai trauma. Hal lain yang berdampak terhadap tenaga kesehatan yaitu kurangnya kepercayaan ibu (Kurniawati, 2015)

Secara global pada tahun 2017, lebih dari 830 wanita meninggal dalam waktu 24 jam karena kasus yang berhubungan dengan kehamilan dan masalah proses persalinan dan 94 % dari semua kematian ibu terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan SDG 3, negara-negara telah berkomitmen untuk menurunkan kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup antara 2015 dan 2030 (Fikadu, et al., 2023)

Menurut maharani (2014) kondisi psikologis ibu yang menjalani proses persalinan mengalami perubahan naik-turun hal tersebut berdasarkan kondisi hubungan suami istri, pengalaman seseorang menghadapi komplikasi persalinan, keinginan yang ideal dalam memiliki keturunan terkait jenis kelamin. Tingkat kepuasan ibu terhadap layanan persalinan memiliki hasil yang berbeda di berbagai negara seperti di Ethiopia (19%), Afrika (78,54%), Mesir (92,54%), Malaysia (79,2%), dan Nepal (89,88 %). Berbagai faktor utama yang mempengaruhi kepuasan ibu di Ethiopia yaitu waktu tunggu yang lama, kondisi janin, durasi persalinan, cara persalinan, privasi yang terjamin. Beberapa sumber mengatakan kepuasan ibu meningkat ditunjukkan buktinya melalui meningkatnya rasa pencapaian dan harga diri wanita, memiliki pengalaman yang positif di masa mendatang, pemberian ASI yang adekuat sehingga terjadi ikatan yang efektif.

Hasil penelitian Zamani, et al (2019) mengatakan terdapat pengaruh antara dukungan social yang dirasakan dari orang terdekat (pasangan) dengan pengalaman ibu menjalani proses persalinan. Dukungan social merupakan hubungan interpersonal yang dapat mengarah pada bantuan emosional jika diperlukan, bantuan ini bisa didapatkan dari keluarga, tetangga, kolega, saudara dan tim medis berupa dukungan psikologis dan informatif kepada ibu. Ibu yang mendapatkan dukungan selama persalinan cenderung akan melahirkan secara spontan, tidak mengalami komplikasi persalinan dan merasa puas dengan pengalaman persalinannya. Sebaliknya dampak yang terjadi jika ibu hamil sampai melahirkan kurang

mendapatkan dukungan seperti kurang efektifnya proses menyusui, rendahnya kecerdasan pada bayi, depresi pascapersalinan, depresi selama kehamilan (Jameei-moghaddam & Mirghafourvand, 2022).

Berdasarkan uraian diatas penulis akan menguraikan pentingnya dukungan social dalam meningkatkan kepuasan ibu menjalani proses persalinan dan mengurangi terjadinya komplikasi yang tidak diinginkan selama proses persalinan berlangsung.

Bab 2

Pemahaman tentang Kepuasan Ibu menjalani Proses Persalinan

A. Pengertian Proses Persalinan

Persalinan merupakan proses yang alami. Persalinan juga merupakan pengalaman yang unik bagi tiap ibu karena dapat memberikan respon yang berbeda beda. Sebagian ibu mengalami persalinan dengan waktu yang cepat dalam hitungan jam atau kurang, sementara yang lain dengan waktu yang lama bahkan sampai dapat menguji batas stamina fisik dan emosional.

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau bayi dalam kandungan. Proses ini bisa jadi hal yang membahagiakan karena menjadi ujung dari kehamilan. Persalinan juga sekaligus bisa menakutkan dan

melelahkan karena prosesnya membutuhkan banyak kesabaran.

Meskipun target utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG3) Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mengurangi tingkat kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, kualitas perawatan intrapartum di sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah secara kronis buruk, dan ini telah diidentifikasi sebagai salah satu prekursor dari tingkat kematian ibu yang tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (UN, United Nations Transforming our world, the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015). Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa sekitar lebih dari delapan ratus lima puluh wanita meninggal karena penyebab yang dapat dicegah terkait persalinan setiap hari, dengan 99% dari semua kematian ibu ini terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2012).

Asuhan keperawatan intrapartum adalah perawatan yang diberikan oleh perawat untuk ibu yang melahirkan selama persalinan. Pemahaman yang baik dan benar tentang proses bersalin oleh petugas kesehatan dan juga oleh pasien sendiri akan membantu meningkatkan kenyamanan ibu selama proses berlangsung. Proses persalinan dimulai ketika tubuh ibu mengalami perubahan untuk mempersiapkan jalan lahir bagi bayi. Serviks akan melebar (dilatasi) untuk membuat lubang yang cukup besar dilalui bayi. Timbulnya kontraksi (kram rahim atau HIS) akan mulai menggerakkan

bayi ke bawah melalui jalan lahir. Proses persalinan akan menghasilkan kelahiran bayi. Seorang bayi dapat lahir melalui vagina atau operasi caesar (seksio sesarea). Ibu dapat mempersiapkan diri dengan memahami rangkaian peristiwa yang biasanya terjadi selama persalinan dan persalinan. Normalnya, persalinan dimulai antara minggu ke-37 dan minggu ke-42 kehamilan. Persalinan yang terjadi sebelum 37 minggu kehamilan dianggap prematur atau tidak matur. Seperti pengalaman kehamilan yang berbeda pada tiap ibu, awal persalinan dan tanda-tanda persalinan serta lamanya waktu untuk menjalani proses bersalin juga bervariasi pada tiap ibu.

Tanda utama persalinan adalah serangkaian kontraksi (keadaan kencang dan kendurnya rahim) yang terjadi secara teratur. Timbulnya kontraksi mulai dari yang pelan dan jarang, bertambah kuat dan sering. Kontraksi kemudian menjadi lebih kuat, bertahan lebih lama, dan lebih sering serta teratur. Pada beberapa ibu kemungkinan dapat mengalami persalinan palsu (kontraksi *Braxton Hicks*). Kontraksi ini biasanya tidak teratur dalam frekuensi dan intensitas. Hal ini terjadi ketika kontraksi lemah atau tidak teratur atau berhenti saat ibu berganti posisi. Kontraksi yang sejati terjadi secara teratur, kontraksi biasanya dirasakan mulai dari fundus rahim dan memanjang ke bawah menuju serviks. Pemeriksaan secara berkala akan dilakukan untuk memantau kemajuan dari proses bersalin.

Bersamaan dengan frekuensi kontraksi yang meningkat, ibu dapat merasakan turunnya janin ke panggul.

Kejadian turunnya atau masuk janin ke panggul disebut sebagai "*lightening*". Proses ini akan terjadi saat segmen rahim bagian bawah mengembang akibat frekuensi dan intensitas kontraksi yang meningkat. Kondisi ini dapat memberikan tekanan yang signifikan pada sakrum yang menimbulkan nyeri. Pada beberapa ibu hamil dapat mengalami nyeri saraf skiatik sekunder akibat perubahan anatomi tersebut. Keadaan lain dengan terjadinya "*Lightening*" menghasilkan peningkatan tekanan pada kandung kemih, sehingga meningkatkan gejala frekuensi buang air kecil. Ibu akan lebih sering buang air kecil.

Tanda-tanda persalinan lainnya seperti perubahan lendir vagina seperti keputihan (vaginal discharge), timbul nyeri atau tekanan di sekitar bagian depan panggul atau rektum, sakit punggung yang rendah dan tumpul, kram yang terasa seperti kram menstruasi yang disertai dengan atau tanpa diare, semburan atau tetesan cairan dari vagina tanda pecahnya selaput ketuban (López-Zeno & Harrington, 2004).

Proses persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu power (kekuatan), passenger (janin), passageway (jalan lahir), posisi ibu dan psychologic respon (respon psikologis). Kelima faktor tersebut penting dalam mendukung kemajuan persalinan. Power meliputi tenaga ibu untuk mengejan dan kontraksi otot-otot polos uterus. Keduanya merupakan sumber tenaga ibu yang berguna untuk mendorong janin keluar dari rahim. Kekuatan tersebut akan mengeluarkan janin atau *passenger* melalui jalan lahir atau *passageway*. Ukuran dan bentuk janin yang sesuai akan membantu

melakukan manuver pada saat pengeluaran janin melalui jalan lahir. Posisi ibu juga mempengaruhi janin dalam penyesuaian terhadap jalan lahir. Posisi yang baik dan benar akan membantu mempermudah proses persalinan. Berikut posisi ibu saat melahirkan (Dekker, 2022 dan Miles, 2024):

1. Posisi berbaring (litotomi)

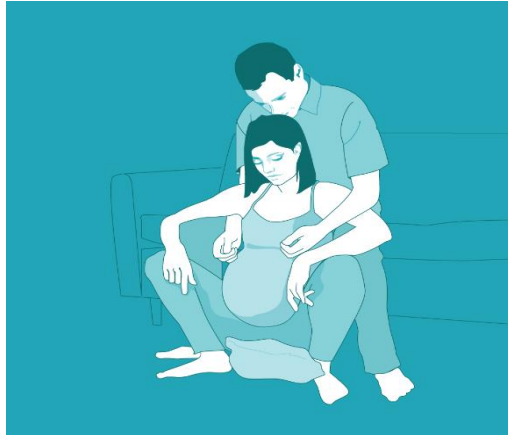
Merupakan posisi paling umum dilakukan oleh ibu hamil yang hendak bersalin. Pada posisi ini, ibu tidur terlentang dan membuka kedua kaki dengan menggantung di penopang kaki yang digunakan secara khusus untuk bersalin.



Gambar 2.1 Posisi Berbaring

2. Posisi jongkok

Posisi jongkok memungkinkan panggul ibu terbuka lebih lebar sehingga janin memiliki ruang untuk bergerak ke jalan lahir lebih lebar. Posisi jongkok memerlukan pendamping untuk menyanggah badan ibu. Salah satu kekurangan dari posisi ini adalah membuat tenaga medis sulit melakukan tindakan.



Gambar 2.2 Posisi Jongkok

3. Posisi berdiri tegak

Posisi ini juga membutuhkan bantuan orang lain untuk menopang ibu. Posisi melahirkan dengan cara ini dibantu oleh gaya gravitasi yang secara natural membuat panggul ibu terbuka lebih lebar dan memudahkan janin untuk bergerak ke jalan lahir.



Gambar 2.3 Posisi berdiri tegak

4. Posisi berlutut

Posisi ini dibantu dengan gravitasi alami yang mempermudah proses persalinan. Pada posisi ini, janin dapat terdorong maju. Posisi ini juga dapat mengurangi tekanan pada punggung ibu sehingga ibu lebih nyaman.

5. Posisi setengah duduk

Posisi ini dapat dilakukan dengan duduk di atas birthing ball atau di atas tempat tidur. Ibu harus berbaring dengan bersandar pada sesuatu yang tinggi sehingga posisi ini terlihat setengah duduk condong terlentang. Posisi ini terbukti dapat meringankan nyeri kontraksi saat proses persalinan. Melalui posisi ini memungkinkan gravitasi alami turut membantu proses persalinan membuat janin terdorong ke jalan lahir lebih mudah.



Gambar 2.4 Posisi setengah duduk

6. Posisi bertumpu pada tangan dan lutut

Posisi ini membantu ibu agar panggul terbuka serta memanfaatkan gaya gravitasi alami untuk mendorong

bayi keluar ke jalan lahir. Posisi ini juga dapat mengurangi rasa nyeri punggung ibu saat melahirkan.



Gambar 2.5 Bertumpu pada tangan dan lutut

7. Posisi berbaring miring (lateral)

Posisi lateral lebih baik dari pada tidur terlentang, hal ini disebabkan oleh pembuluh darah utama dalam tubuh ibu tidak akan tertekan sehingga aliran darah ke janin tidak terhambat. Namun, kekurangan posisi ini adalah menyulitkan tenaga medis melakukan tindakan medis.



Gambar 2.6 Lateral

Psychologic respon atau respon psikologis merupakan kondisi psikologis ibu yang turut berperan mempengaruhi kemajuan persalinan. Dorongan positif, persiapan persalinan, pengalaman persalinan lalu dan strategi adaptasi atau coping ibu akan memberikan dampak positif dalam persalinan.

Ketidaknyamanan akibat nyeri yang dialami pada persalinan dirasakan sebagai akibat dari kontraksi otot di uterus/rahim. Nyeri yang dialami mulai awal sampai persalinan berakhir (Bobak, Lowdermilk & Jensen, 2012; Muaningsih dkk, 2022). Nyeri proses persalinan adalah unik dengan kualitas dan intensitas nyeri yang bervariasi pada setiap ibu. Kontraksi yang terjadi selama persalinan umumnya digambarkan sebagai perasaan nyeri yang sangat dalam. Pada beberapa ibu dengan pengalaman melahirkan sebelumnya mempunyai potensi yang besar dalam beradaptasi terhadap nyeri yang dialami selama persalinan, karena tingkat kecemasan ibu dapat berkurang jika seseorang mengetahui kapan waktu terjadinya nyeri dan lama berlangsungnya ketidaknyamanan tersebut.

Beberapa tindakan penanganan terhadap nyeri persalinan telah dikembangkan baik melalui metode nonfarmakologi maupun farmakologi. Penanganan nyeri secara nonfarmakologi dapat membantu mengurangi persepsi nyeri yang dialami oleh ibu selama proses bersalin dan biasanya terapi ini bersifat lebih aman. Metode dapat diajarkan dalam kelas prenatal atau kelas persiapan melahirkan. Menurut Jones et al (2012) dan Bobak,

Lowdermilk & Jensen (2012) beberapa penanganan nyeri non-farmakologi untuk meringankan rasa nyeri sebagai berikut:

1. Aromatherapy

Penggunaan minyak esensial selama kehamilan dan melahirkan merupakan salah satu terapi yang digunakan dapat memberikan efek menenangkan.



Gambar 2.7 Aromatherapy

2. Immersion in water

Berendam dalam air hangat selama proses bersalin dapat dilakukan untuk memberikan rasa relaksasi dan mengurangi rasa sakit.



Gambar 2.8 Berendam air hangat

3. Teknik relaksasi (yoga, musik, audio)

Teknik relaksasi bertujuan untuk relaksasi, melepaskan ketegangan otot-otot, memberikan efek menenangkan, dan sering dilakukan bersamaan dengan latihan pernafasan meditasi dan visualisasi.



Gambar 2.9 Relaksasi

4. Hipnosis

Self hypnosis dapat dilakukan ibu selama persalinan untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi uterus.

5. Biofeedback

Prinsip terapi ini untuk perubahan pikiran dan emosi. Biofeedback (umpan balik biologis) merupakan terapi latihan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui sinyal yang didapatkan dari tubuh mereka sendiri (termasuk suhu, detak jantung, ketegangan otot).

6. *Intracutaneous or subcutaneous sterile water injection*

Injeksi air steril di intrakutan atau intradermal di atas sakrum telah terbukti mengurangi rasa sakit saat melahirkan.

7. Akupuntur atau akupresure

Akupuntur merupakan suatu terapi yang melibatkan penusukan jarum halus ke berbagai tubuh tertentu (memberikan tekanan pada titik-titik akupuntur). Titik akupunture yang digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan biasanya terletak di tangan, kaki dan telinga.



Gambar 2.10 Akupuntur

8. Massage, refleksiologi dan metode manual lainnya
Masase atau pijatan merupakan jenis stimulasi pada kulit untuk membantu mengurangi nyeri selama persalinan. Stimulasi dilakukan mulai dari yang ringan sampai sedang biasanya akan lebih efektif dibanding stimulasi kuat. Tindakan menggosok punggung bawah dengan tekanan yang kuat diantara sakrum selama kontraksi juga dapat dilakukan.
9. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
TENS merupakan bentuk pereda nyeri yang dikontrol sendiri, digunakan selama kala satu persalinan. Efektifitasnya beragam dan lebih efektif jika alat ini digunakan sejak awal kontraksi, sebelum persalinan secara pasti terjadi.

Terdapat beberapa metode persalinan yaitu Persalinan normal Persalinan seksio sesaria dan Persalinan dengan penggunaan vakum atau forsep. Persalinan biasa atau persalinan normal disebut juga partus spontan yaitu proses lahirnya bayi pada letak belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi umumnya berlangsung kurang dari 24 jam. Persalinan spontan berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri.

Persalinan luar biasa (abnormal) yaitu persalinan pervaginam dengan bantuan alat-alat atau melalui sayatan pada dinding perut dengan operasi. Persalinan dengan alat bantu terjadi ketika bayi membutuhkan bantuan untuk dilahirkan. Metode umum dalam persalinan dengan bantuan yaitu dengan forceps dan vakum. Persalinan seksio sesaria

adalah persalinan melalui sayatan pada dinding abdomen dan uterus yang masih utuh dengan berat janin >1.000 gr atau umur kehamilan 28 minggu. Persalinan seksio sesaria diharapkan dapat menjamin turunnya tingkat morbiditas dan mortalitas pada ibu.

Terdapat beberapa metode persalinan yaitu:

- 1) Persalinan normal yaitu ibu melahirkan janinnya per vaginam saat bayi baru lahir berusia cukup bulan pada usia kehamilan 37 hingga 42 minggu persalinan ini dapat terjadi jika selaput ketuban pecah, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu persalinan spontan ini dapat terjadi jika ibu bersalin mengalami kontraksi teratur dengan dilatasi serviks 10 cm, jika hanya kontraksi saja tanpa disertai dilatasi serviks maka ibu yang akan bersalin segera dipulangkan dengan tindak lanjut pemantauan rutin denyut jantung janin dan pemantauan kontraksi, namun wajib dilakukan perawatan dengan pemberian induksi persalinan, jika dilatasi serviks ada namun kontraksi tidak ada (Desai, 2023).
- 2) Persalinan seksio sesaria dilakukan melalui sayatan di perut dan rahim ibu, ketika persalinan per vaginam tidak bisa dilakukan seperti prolaps tali pusat, litak lintang, prolaps tali pusat, posisi plasenta abnormal adanya infeksi seperti wabah herpes genital aktif dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan pasca operasi yaitu adanya perasaan mual, pusing, atau gatal akibat obat-obatan yang digunakan untuk membius ibu selama

manjalani operasi seksio sesaria. Tanda dan gejala lain yang dapat dirasakan yaitu keputihan, nyeri pascapersalinan, pembengkakan dan nyeri pada payudara, perubahan rambut dan kulit yang menipis, merasa sedih (terjadi baby blues)



Gambar 2.11 Operasi

- 3) Persalinan dengan Intervensi: proses persalinan ini dimulai secara buatan, yang prosesnya melibatkan penggunaan obat-obatan untuk memulai kontraksi sehingga serviks membuka

B. Kepuasan Ibu Menjalani Proses Persalinan

Kepuasan erat kaitannya dengan kualitas dari suatu layanan yang didapatkan oleh konsumen. Bahkan kepuasan diidentifikasi sebagai indeks utama untuk menilai kualitas penyediaan layanan kesehatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepuasan berasal dari kata puas yang diartikan sebagai merasa senang (lega, gembira, kenyang, dan sebagainya karena sudah terpenuhi hasrat

hatinya). Kepuasan merupakan kesenangan atau keadaan psikis yang menyenangkan yang dirasakan karena terpenuhinya semua kebutuhan secara memadai. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa terhadap sesuatu.

Kepuasan (*satisfaction*) konsumen/pelanggan adalah evaluasi atau penilaian seseorang berupa perasaan senang atau kecewa yang terjadi saat purna beli setelah membandingkan antara apa yang dirasakan (hasil) dengan harapan-harapannya terhadap suatu produk atau layanan jasa yang digunakan. Begitu juga dalam layanan keperawatan khususnya layanan dalam proses persalinan. Kepuasan ibu terhadap layanan keperawatan selama masa persalinan (intrapartum) mengukur kemampuan layanan untuk memenuhi harapan konsumen dalam hal ini ibu hamil, dan merupakan penentu penting dari pilihan fasilitas kesehatan dan pemanfaatannya di masa depan untuk layanan persalinan dan persalinan (Srivastava, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan pada ibu tentang kepuasan dalam layanan selama perawatan antenatal, intrapartum, dan postnatal menunjukkan bahwa kepuasan peserta berkaitan dengan kualitas perawatan yang mereka terima selama perawatan (Okonofua, et al, 2017). Pengalaman ibu yang merasa puas dengan persalinannya akan memberikan perasaan bahagia dengan kehadiran bayinya. Hal ini juga memberikan dampak yang positif pada kemudahan dalam menyesuaikan diri dan kesiapan memulai peran baru menjadi ibu. Sebaliknya, pengalaman traumatik

saat persalinan dapat mempengaruhi kemampuan ibu dalam kesiapan mengasuh dan memberikan air susu ibu (ASI) serta dapat mengakibatkan dampak buruk pada ikatan (*bonding*) ibu dan bayinya (Ramie dkk, 2014).

Berbagai metode persalinan akan mempengaruhi kepuasan ibu dalam menjalani proses persalinan yaitu ditemukan ibu yang melahirkan secara normal mendapatkan kepuasan yang jauh lebih besar dan lebih sedikit mengalami stress dibandingkan dengan ibu yang menjalani proses seksio caesaria. Ibu yang menjalani persalinan dengan seksio sesaria, induksi persalinan dan kala dua yang lama memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang lahir normal (Bossano, dkk, 2017). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Volkert et al. (2024), ibu yang menjalani persalinan dengan Tindakan operasi seksio caesaria menyatakan ketidakpuasan yang jauh lebih tinggi terhadap pengalaman melahirkan dibandingkan dengan ibu yang melahirkan secara normal tanpa intervensi apapun.

C. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Ibu Bersalin

Kepuasan ibu dalam mendapatkan layanan perawatan dipengaruhi banyak hal. Bahwa rumah sakit yang besar yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan juga tidak menjamin pasiennya lebih puas terhadap layanan dibandingkan dengan pasien yang diwat di rumah sakit yang lebih kecil. Hasil penelitian Okonofua dkk (2017) yang dilakukan di salah satu rumah sakit rujukan tersebut menyebutkan bahwa perlu adanya peningkatan untuk perawatan ibu bersalin juga

peningkatan fasilitas rumah sakit, reorganisasi layanan untuk menghilangkan penundaan, pelatihan dan pelatihan ulang tenaga kesehatan, serta umpan balik/konseling dan perlu peningkatan pendidikan perempuan.

Berbagai penelitian yang dilakukan di negara maju dan berkembang termasuk Ethiopia menunjukkan bahwa tindak lanjut perawatan masa hamil (ANC), status pendidikan, waktu tunggu, ketersediaan obat-obatan dasar, kebersihan lingkungan, ruang bersalin dan bangsal, biaya yang dibayarkan untuk layanan dan ruang tunggu, privasi, status pendidikan, dan kompetensi teknis penyedia layanan kesehatan adalah faktor utama yang terkait dengan kepuasan ibu terhadap layanan selama persalinan (Tesfaye, et al, 2016; Sayed et al, 2018).

Faktor-faktor yang secara signifikan berkaitan dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah adalah jenis persalinan kelahiran caesar, tingkat kepercayaan, manajemen nyeri farmakologis, tindakan pemantauan detak jantung janin terus menerus, dan episiotomi. Nulliparity juga dikaitkan dengan kepuasan ibu minimal. Kepuasan yang lebih besar dikaitkan dengan pendamping oleh pendamping pilihan selama persalinan (Weeks, 2016). Senada dengan hal di atas, berdasarkan hasil yang dikumpulkan tentang kepuasan ibu juga dipengaruhi oleh penyedia layanan kesehatan, karakteristik demografis, dan berbagai pengalaman kehamilan, persalinan, kelahiran, dan pasca persalinan (Ramie, 2014).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan ibu saat bersalin antara lain:

1. Pekerjaan

Pekerjaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan ibu diluar rumah yang merupakan cara untuk menambah penghasilan. Ibu yang bekerja memiliki kemampuan mendapatkan persalinan yang memuaskan dikarenakan memiliki wawasan, pandangan dari berbagai aspek, sehingga mampu menyiapkan berbagai hal dalam menghadapi persalinan dengan baik (Hendriani 2006).

2. Pendidikan

Pendidikan akan mempengaruhi ibu dalam bersikap, mengambil keputusan dalam hal ini mempersepsikan nyeri yang dirasakan serta cara mengatasi nyeri tersebut, sehingga tingkat pendidikan ibu yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan ibu dalam menjalani proses persalinan (Goodman, Mckey dan Tavkoli, 2004). Pendidikan ibu mempengaruhi tingkat kepuasan dalam menjalani persalinan yaitu pada ibu dengan sekolah menengah mengalami tingkat kepuasan yang lebih baik saat menjalani proses persalinan dibandingkan dengan ibu dengan lulusan diploma (Gizew, 2018).

3. Paritas

Paritas adalah jumlah kelahiran yang pernah ibu alami. Diklasifikasikan menjadi multipara, primipara. Menurut sarah (2010), ibu primipara memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi saat menjalani proses persalinan, hal ini terjadi karena proses persalinan merupakan pengalaman

yang baru dirasakan. sedangkan pada ibu multipara, kepuasan persalinan akan mudah didapat, dikarenakan telah memiliki pengalaman sebelumnya, serta mampu melakukan hubungan interpersonal dengan petugas pelayanan yang baru ditemui saat menjelang persalinan.

4. Usia

Usia ibu yang menjalani persalinan lebih dari 20 tahun akan mudah mengalami atau mendapatkan kepuasan dalam menjalani proses persalinan, dikarenakan usia tersebut telah menginjak dewasa yang mana aspek kognitifnya sudah mampu berkembang baik, sehingga mampu menerima arahan petugas kesehatan dengan baik sehingga mudah tercapai kepuasan persalinan.

5. Penghasilan keluarga

Penghasilan keluarga yang baik, akan mempengaruhi kepuasan ibu dikarenakan penghasilan dapat diartikan dengan status ekonomi, yang artinya status ekonomi yang baik akan membuat ibu mampu mengambil keputusan untuk menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan.

6. Efikasi diri

Keyakinan ibu dalam menghadapi proses persalinan tentunya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi ibu, riwayat bersalin, pengetahuan ibu tentang proses persalinan. Efikasi diri yang positif akan berdampak terhadap kepuasan diri yang positif. Menurut Lowe, Perrin & Tanglakmankhong (2010), efikasi diri yang tinggi dapat menurunkan kemampuannya untuk

menghadapi/mengatasi kesulitan dalam proses persalinan.

7. Nyeri Persalinan

Berbagai macam pandangan terkait persepsi nyeri dengan kepuasan ibu menjalani persalinan sangat bervariasi. Persepsi yang negatif terhadap nyeri persalinan akan membuat ibu lebih cemas selama persalinan dan menjadikan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi ibu (Cristian dan Bracke, 2007).

8. Kualitas Pelayanan Tenaga Medis

Kualitas perawatan yang diberikan tenaga medis terhadap ibu bersalin di negara Ethiopia mendapatkan nilai kepuasan > 70%. (Edaso, 2019)

- a. (Kompetensi dan keterampilan Teknis tenaga medis (perawat, dokter, bidan).
- b. Empati, komunikasi dan sikap mendukung dari tenaga medis

9. Lingkungan Fasilitas Kesehatan

- a. Kebersihan Ruang Bersalin dan kamar pemulihan, hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi nosocomial pada ibu dan bayi baru lahir, ruang bersalin yang bersih dapat meningkatkan rasa nyaman pada ibu dan meningkatkan kepercayaan pada ibu bersalin terhadap pemberi pelayanan kesehatan.
- b. Ketersediaan peralatan medis dan kenyamanan fasilitas

Ibu bersalin di negara Ethiopia mengatakan 3,15 kali lebih puas datang fasilitas kesehatan untuk bersalin dikarenakan fasilitas kesehatan menggunakan layanan ambulance untuk menjemput pasien saat bersalin.

10. Dukungan Sosial dan keluarga

- a. Kehadiran suami atau keluarga selama proses persalinan



Gambar 2.12 Kehadiran Suami

- b. Pentingnya dukungan emosional dari lingkungan sekitar

11. Faktor psikologis dan budaya

a. Pengaruh budaya terhadap persepsi kepuasan

Selama kehamilan dan persalinan, kepuasan ibu bersalin dipengaruhi oleh praktik dan kepercayaan yang diatur oleh budaya seseorang, dimana tradisi dan kepercayaan local memiliki peran penting dalam proses ini. Misalnya di daerah baduy, paraji atau dukun bayi memiliki peran penting sebagai pendamping persalinan. Dengan adanya kehadiran pendamping persalinan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi ibu bersalin karena mereka memiliki ikatan kekeluargaan dan kepercayaan yang sangat kuat. Hanya saja praktek dukun bayi/paraji memiliki risiko terkait standar kesehatan yang mungkin tidak sesuai dengan standar operasional praktek persalinan (Nurlaili, 2023).

Pengaruh budaya dan tingkat pengetahuan ibu akan mempengaruhi ibu dalam menentukan tempat bersalin, ibu dengan pengetahuan yang kurang baik, akan memilih bersalin di non fasilitas kesehatan, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap tingkat kepuasan ibu selama persalinan. (Selina dkk, 2023). Faktor social-budaya di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah suami sebagai pengambil keputusan dalam keluarga yang memiliki tugas dalam pencarian layanan dan tempat persalinan.

b. Kepercayaan dan harapan individu terhadap persalinan

Setiap ibu bersalin menginginkan pengalaman persalinan yang positif sesuai dengan harapan dan keyakinannya yang terdiri dari melahirkan bayi yang sehat dilingkungan yang aman dan ibu mendapatkan asuhan yang komprehensif yang terdiri dari adanya dukungan, terdapat rasa aman yang diberikan dari penolong persalinan, namun setiap ibu memiliki harapan yang berbeda dalam menjalani persalinan, hal tersebut berdasarkan pengetahuan, pengalaman, keyakinan, budaya, social dan latar belakang keluarga (Zulala dan Erfanda, 2019).

Bab 3

Dukungan Sosial dalam Meningkatkan Kepuasan Ibu Menjalani Proses Persalinan

A. Pengertian Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan bentuk bantuan yang dapat dirasakan di lingkungan sekitar dimana orang tersebut tinggal, bekerja, belajar dan bermain. Dukungan social (social Support) yang baik dapat meningkatkan rasa nyaman dan menjauhi serta mengatasi masalah kesehatan mental seseorang. Pada ibu hamil yang akan menjalani proses persalinan membutuhkan dukungan social. Dukungan social bisa didapat dari lingkungan social tertentu seperti suami, orangtua, mertua, teman dan tetangga yang menjadikan ibu merasa diperhatikan, dihargai dan dicintai Dukungan social bagi ibu yang akan

menjalani proses persalinan paling berarti dari pasangannya yaitu suami.

B. Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dukungan sosial yaitu keintiman, harga diri dan keterampilan sosial. 1) keintiman didapatkan dari dukungan sosial yang dirasakan dari sebuah hubungan yang lebih dekat yang akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kenyamanan. Kurangnya keintiman antara hubungan ibu dan suami akan menyebabkan rendahnya dukungan. Rendahnya keintiman dapat dilihat dari kualitas atau keharmonisan hubungan antara istri dan suami yang menyebabkan suasana tidak nyaman, kurangnya perhatian atau kurang menerima kasih sayang. Selain keintiman hubungan kepercayaan ibu terhadap dukungan yang diberikan oleh suami menjadi factor yang mendasarinya. Kurangnya kepercayaan atau keraguan ibu terhadap dukungan pasangan dapat menyebabkan rendahnya dukungan yang akan diterima, ibu yang meragukan ketersediaan suami dalam memberikan dukungan cenderung kurang percaya diri dalam mengatasi masalah. Kurangnya kuantitas 2) Harga diri yaitu, persepsi seseorang bagaimana memandang dirinya tidak mampu dikarenakan mencari bantuan, 3) keterampilan sosial, dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, bentuk-bentuk keluarga, tahap siklus kehidupan keluarga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis ibu yang menjalani proses persalinan yaitu keinginan ideal seseorang memiliki bayi dengan jenis kelamin tertentu, penerimaan terhadap kehamilan yang sedang dijalannya, kondisi hubungan suami istri, kondisi ketersediaan sumber sosial, pengalaman seseorang menghadapi komplikasi persalinan.

C. Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Proses Bersalin

Menurut Jameei-Moghaddam and Mirghafourvand, (2022) Ibu yang sedang menjalani proses persalinan yang terus menerus mendapatkan dukungan dari siapapun baik bidan, perawat, keluarga, suami dan lain-lain akan berpengaruh dalam mengurangi durasi persalinan, meningkatkan angka persalinan spontan pervaginam, mengurangi akan obat pereda nyeri saat persalinan dan menghasilkan pengalaman yang positif. Penambahan lamanya persalinan yang berlebihan akan dapat meningkatkan risiko kecemasan, insomnia, kemungkinan infeksi, cedera fisik dan saraf, serta kematian embrio atau anak dan meningkatkan risiko perdarahan bagi ibu, infeksi pasca persalinan, gangguan mental dan kelelahan.

Proses persalinan yang didampingi oleh orang terdekat terutama suami membuat ibu merasa lebih tenang dan nyaman. Suami/keluarga dapat menemani di ruangan tunggu yang telah disediakan. Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh suami atau keluarga yaitu seperti menggenggam tangan sang ibu saat proses bersalin

berlangsung. Memberikan semangat dan perhatian kepada isteri, bicara halus dan positif.

D. Beberapa Aspek Dukungan Sosial

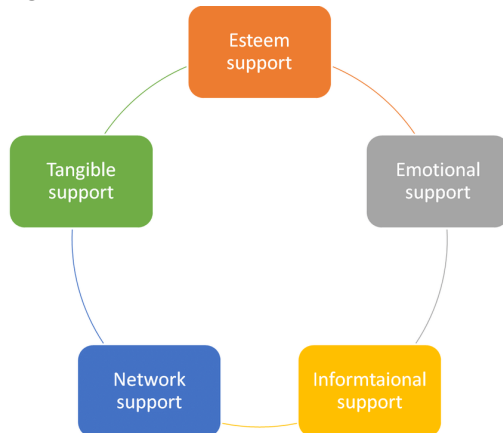
Menurut Patil & Ayadi, (2024) terdapat beberapa aspek dukungan sosial yang terdiri dari:

1. Dukungan emosional
Meliputi ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadap seorang individu sehingga tercapai rasa nyaman, dicintai dan diperhatikan, seperti membina hubungan yang baik, bicara halus, positif dan lain sebagainya.
2. Dukungan Keuangan, merupakan bantuan keuangan dari suami, mertua atau orangtua untuk biaya yang berkaitan dengan biaya persalinan. Meliputi biaya yang dikeluarkan selama kehamilan (termasuk pemeriksaan medis, USG, kebutuhan lain dan biaya persalinan), kemampuan mengakses layanan kesehatan yang memadai, membeli perlengkapan yang diperlukan dan menanggung biaya medis serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan ibu hamil secara keseluruhan.
3. Dukungan instrumental, mencakup kebutuhan seorang individu yang diberikan secara langsung dalam bentuk jasa, seperti membantu mengerjakan tugas rumah tangga dan pengasuhan anak, bantuan ini sangat berguna bagi ibu hamil terutama pada tahap akhir kehamilan. Dukungan ini didapat dari anggota keluarga,

terutama ibu dan ibu mertua dalam mengelola pekerjaan rumah tangga, memasak dan merawat anggota keluarga lainnya. Disarankan ibu tidak berpergian untuk menghindari ketidaknyamanan

4. Dukungan Informasi

bentuk dukungan social yang pemberiannya lebih mudah diberikan karena sifat bantuannya lebih efisien dan efektif, yang penyampaianya tidak memerlukan keadekuatan interpersonal namun diberikan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Mencakup berupa saran, pengarahan dan umpan balik mengenai pemecahan dari permasalahan contoh informasi dari keluarga yang berpengalaman langsung dengan kehamilan dan persalinan menjadi panduan bagi ibu hamil. Mencakup berupa saran, pengarahan dan umpan balik mengenai pemecahan dari permasalahan.



Gambar 3.1 Jenis-Jenis Dukungan Sosial
Sumber: (Visvalingam et al., 2019)

Berdasarkan gambar diatas didapatkan beberapa jenis dukungan social yaitu:

- 1) *Esteem support*, Dukungan ini mengacu pada validasi "konsep diri", kepentingan, kompetensi, yang berarti kemampuan untuk meningkatkan harga dirinya agar terjadi beberapa kemajuan dalam hidupnya. Contohnya meningkatkan harga diri seseorang dengan cara menanamkan keyakinan bahwa ia dapat menyelesaikan tugasnya sendiri dan melakukan yang terbaik tanpa dukungan eksternal, yang pada akhirnya disadari bahwa ia dapat menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa dukungan eksternal, hal ini dapat memberinya kepuasan diri yang besar.
- 2) *Emotional support*, Dukungan ini diberikan melalui komunikasi, cinta dan perhatian terhadap seseorang. Ada beberapa jenis dukungan emosional yang diberikan melalui kasih sayang fisik, dorongan, pengertian, kerahasiaan, doa dan simpati. Kasih sayang fisik dalam konteks ini mengacu pada memberikan motivasi seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya. Doa adalah sarana untuk memotivasi satu sama lain menuju jalan spiritual dan membantunya untuk lebih focus pada apa yang ingin dicapainya tanpa merasa tersisih. Simpati berarti mempertimbangkan bagaimana perasaan orang lain terhadap suatu situasi yang dialaminya dan berempati terhadapnya.
- 3) *Informational support*, Dukungan ini mencakup arahan untuk melaksanakan tugas, saran tentang cara

melakukannya, merujuk kepada individu yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing, dan evaluasi situasi, dimana informasi yang disampaikan bermaksud agar seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih percaya diri tanpa mengalami keraguan tentang hasilnya. Dan yakin akan memberikan hasil yang positif karena telah dilakukan, dialami dan diuji.

- 4) *Network support*, dukungan ini bekerja dengan menciptakan hubungan structural dalam suatu lingkaran. Dukungan ini membantu seseorang untuk diperkenalkan kepada orang-orang yang belum pernah ditemui sebelumnya yang telah mengalami situasi yang hampir sama yang dialaminya saat ini. Ditemukan dengan orang yang berbeda akan membuat seseorang menyadari bahwa apa yang dialaminya bukanlah sesuatu hal yang baru dan ada kemungkinan solusi untuk itu.
- 5) *Tangible support*, Dukungan ini melibatkan orang ketiga yang memberikan bantuan fisik kepada orang yang membutuhkan dukungan.

Faktor lain yang memengaruhi proses persalinan pada ibu adalah

1. Akses Ke fasilitas kesehatan

Hal ini sangat penting bagi ibu yang mengalami risiko dalam kehamilannya yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam menentukan lingkungan yang sesuai selama kehamilan dan persalinan.

2. Kenyamanan

Kenyamanan merupakan aspek terpenting bagi ibu hamil yang berdampak langsung pada kesejahteraan fisik dan emosional ibu

3. Peran Suami

Merupakan Aspek penting, tempat ibu mencari dukungan emosional, namun suami tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan yang efektif selama persalinan

Beberapa ibu memiliki tradisi pindah sementara ke rumah ibu kandungnya saat melahirkan pertama, keputusan ini memiliki beberapa faktor pertimbangan seperti ketersediaan pengasuh, akses transportasi dan kedekatan dengan fasilitas kesehatan jika terjadi keadaan darurat. Pertimbangan keuangan seperti ketersediaan sumber daya dan stabilitas keuangan memengaruhi pilihan tempat tinggal selama kehamilan dan persalinan. Pilihan lokasi juga bergantung pada ketersediaan transportasi dan kedekatan dengan fasilitas kesehatan, terutama pada kehamilan beresiko tinggi atau saat ibu hamil mengalami potensi komplikasi kesehatan.

D. Sumber Dukungan Sosial

Terdapat beberapa sumber dukungan social yaitu

1. Keluarga

Merupakan tempat berkumpul dan berbagi cerita, berbagi keluh kesah dalam menghadapi kehidupan, karena dalam keluarga tercipta rasa saling percaya. Banyak Wanita memilih untuk Kembali ke rumah

kelahirannya saat akan melahirkan karena mereka menemukan kepastian dan dukungan emosional dari ibu kandung mereka, yang dapat diandalkan, dikarenakan Wanita yang baru menikah tidak membentuk ikatan yang erat dengan ibu mertua. Menurut Mane UR (2024), hasil penelitian yang dilakukan pada 344 peserta, 168 (48,83%) menerima dukungan dari ibu, 42 (12,20%) menerima dukungan dari suami, 37 (10,75 %) dari ibu mertua dan 10 wanita (2,91%) menerima dukungan dari kerabat lain, dan sekitar 87 (25, 29 %) tidak menerima dukungan dari kerabat mereka dan hasilnya dukungan keluarga yang baik terbukti akan berdampak positif pada saat persalinan.

2. Suami

Hubungan suami dengan istri merupakan sebuah hubungan yang sangat erat, dan memiliki kesamaan minat dan tujuan hidup. Pasti mereka saling berbagi perasaan dan saling mendukung dalam berbagai hal, serta dalam menyelesaikan masalah. Menurut Adapun ciri-ciri suami yang memberikan dukungan social kepada ibu diantaranya memberikan Tindakan suportif, meningkatkan rasa aman, dan memberikan bantuan, meluangkan waktu dan memberikan motivasi.



Gambar 3.2 Memberikan posisi yang nyaman bagi ibu bersalin
Sumber: (WHO, 2013)

E. Bentuk Dukungan Sosial

Menurut Vidayanti dan Pratiwi (2019) dukungan sosial dari suami akan membuat ibu lebih tenang dalam menghadapi proses persalinan. Suami memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan dorongan kepada istri selama proses kehamilan dan persalinan. Karakteristik suami yang memberikan dukungan yaitu memberikan Tindakan suportif baik fisik maupun psikologis, memberikan rasa aman, meluangkan waktu dan memberikan motivasi. Beberapa bentuk dukungan social yaitu

1. Mendampingi Ibu saat melakukan pemeriksaan kehamilan
2. Menjaga Komunikasi
3. Menemani Sang Ibu bersalin dengan memberikan sentuhan, motivasi dan pendampingan serta doa untuk

mengurangi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan serta membuat ibu lebih bersemangat dalam melahirkan anaknya.

4. Menjaga bayi bergantian pada malam hari
5. Merawat bayi saat dirumah
6. Mengajak ibu beraktivitas
7. Menyediakan transportasi
8. Biaya persalinan

F. Komponen Dukungan Sosial

Terdapat Beberapa komponen Dukungan Sosial yaitu

1. Kerekatan emosional
2. Integritasi Sosial
3. Adanya Pengakuan
4. Ketergantungan yang dapat diandalkan
5. Bimbingan
6. Kesempatan untuk Mengasuh

Bab 4

Strategi dan Intervensi untuk Meningkatkan Kepuasan Ibu Bersalin termasuk Cara Mendapatkannya

A. Peran Pendamping Persalinan

Pendamping persalinan (atau dukungan sosial selama persalinan) terbukti dapat meningkatkan keseluruhan pengalaman persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menerima dukungan sosial yang baik selama persalinan dan melahirkan cenderung memiliki waktu persalinan yang lebih singkat, mampu mengendalikan rasa sakit dengan lebih baik, dan tidak terlalu membutuhkan intervensi medis. Sesi ini berfokus pada dukungan emosional, kepastian, dan rasa hormat yang dapat diberikan kepada seorang ibu selama proses persalinan.

Pendamping persalinan diwajibkan untuk memahami perasaan dan keinginan ibu yang akan menjalani persalinan. Informasi yang tepat wajib diberikan terkait peran yang harus dilakukan untuk membantu ibu agar lancar dalam menjalani proses persalinan, namun perlu juga didiskusikan kepada ibu terlebih dahulu jika fasilitas ruangan tidak mengijinkan pendamping persalinan adalah suaminya disertai alasan yang dapat diterima, misal dikarenakan kurang privacy di ruang bersalin dan diperbolehkan pendampingnya adalah Wanita bukan pria.

Menjadi pendamping selama proses persalinan adalah sebuah keistimewaan dan kehormatan, tetapi juga merupakan tugas berat, penuh kewajiban dan tanggung jawab. Beberapa peran yang diperlukan sebagai pendamping persalinan adalah sebagai Advokat, menawarkan dukungan fisik dan emosional yang berkelanjutan

Sebagai Advokat, dapat menggunakan akronim BRAIN untuk pengambilan keputusan selama persalinan (B= apa manfaatnya?, R= Apa risikonya ?, A=Apakah ada alternatif ?, I=Apa yang dikatakan intuisi anda?, N=Bagaimana kalau kita tidak melakukan apapun?

B. Kemampuan yang Harus dikembangkan

1. Tunjukan rasa Empati dan rasa hormat yaitu berkomunikasi dengan sopan, menjaga privasi dan kerahasiaan

2. Berikan kata-kata dukungan, dorongan dan Motivasi. Beberapa saran meliputi: "Kamu sangat kuat", "Kamu bisa melakukan hal-hal yang sulit".

C. Kemampuan yang Harus Dipelajari

1. Menjaga privasi dan kerahasiaan selama persalinan dan melahirkan
2. Menjaga rasa hormat dan sopan santun kepada ibu yang sedang bersalin dan pendamping persalinannya
3. Menunjukkan dukungan dan dorongan kepada ibu selama persalinan dan melahirkan
4. Mengkomunikasikan kepada pendamping persalinan tentang pentingnya peran mereka dan apa saja yang terlibat didalamnya.

D. Dukungan dan Perawatan Selama Persalinan dan Kelahiran

Persalinan adalah pengalaman yang sangat emosional dan bagi sebagian orang (terutama suami/pasangan), keterlibatan yang lebih aktif dapat membuat seluruh proses menjadi lebih istimewa. Dan sebaliknya Persalinan dapat menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bagi Wanita, terutama kelahiran pertama. Selain itu, Wanita akan mengalami sensasi fisik mulai dari ketidaknyamanan hingga nyeri hebat. Membantu ibu yang akan menjalani proses persalinan untuk meminimalkan nyeri fisik dan tekanan emosional selama persalinan dan kelahiran dengan cara memberikan informasi, memberikan perawatan yang memadai, kenyamanan, dukungan dan kepastian selama

persalinan dan kelahiran, serta penting juga menjaga rasa hormat dan privacy ibu dengan menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan, serta senantiasa selalu mengkondisikan ruangan selalu tertutup / menyediakan tirai.

Ibu yang akan menjalani proses persalinan difasilitasi untuk memiliki pendamping yang merupakan pilihannya sendiri. Beberapa ibu ingin ditemani oleh suami atau pasangannya yang lain lebih suka ditemani oleh kerabat dekat, teman atau tenaga medis profesional. Namun memotivasi suami/pasangan untuk lebih terlibat dalam proses persalinan, jika dapat diterima, juga dapat bermanfaat bagi seluruh keluarga.

Selama persalinan, jaga komunikasi dengan ibu dan pendampingnya. Menjaga komunikasi berarti memberi tahu ibu sebisa mungkin tentang segala hal yang terjadi dan segala hal yang akan dilakukan atau direncanakan. Berikan penjelasan dengan detail terkait prosedur persalinan yang akan dilakukan, yang berguna meminimalkan kecemasan dan memberikan kepastian segala sesuatu yang dilakukan semuanya dikerjakan secara rutin, termasuk meminta izin. Ketika akan melakukan setiap Tindakan yang merupakan bagian dari menghormati dan kesopanan. Berikan informasi secara terus-menerus terkait kemajuan persalinan, dikarenakan informasi tentang persalinan setiap ibu memiliki perbedaan.

Dukungan pasangan (suami) meningkatkan kesiapan ibu untuk menghadapi proses persalinan dengan memberikan perhatian dan membangun hubungan yang

baik dengan ibu, sehingga ibu dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada pasangan. Diharapkan dukungan suami akan membuat ibu merasa tenang sehingga ibu dapat menghadapi proses persalinan dengan lancar. Hasil penelitian Selamita dkk (2022) terdapat 181 orang (93,8%) yang mengatakan dukungan suami sangat penting untuk mengurangi kecemasan dalam menghadapi proses persalinan. ibu hamil Bentuk dukungan suami yang dapat diberikan yaitu memberikan rasa kepedulian dan menjalin ikatan yang harmonis dengan ibu hamil sehingga ibu dapat mengungkapkan perasaannya kepada suaminya. Dalam menghadapi proses persalinan keberadaan suami memberikan rasa damai dan mengurangi kecemasan. Hal tersebut yang membuat ibu siap dalam menghadapi proses persalinannya.

Menurut Selamita dkk, (2021) dukungan suami terhadap ibu yang menghadapi proses persalinan dapat mengakibatkan perasaan bahagia sehingga adanya ketenangan batin, yang membuat ibu dapat menyesuaikan diri terhadap proses persalinannya. Pernyataan ini dapat didefinisikan bahwa dukungan emosional yang diberikan merupakan suatu bentuk kasih sayang suami terhadap isteri dimana suami setia menunggu sampai bayi lahir.

E. Tingkatkan Perawatan Diri

Persalinan terkadang dapat berlangsung berjam-jam dan ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pendamping persalinan dan ibu yang akan menjalani proses

persalinan yaitu :anjurkan untuk mandi atau membersihkan alat kelaminnya pada awal persalinan dan anjurkan untuk bergerak dan mencari posisi yang paling nyaman, motivasi ibu untuk meningkatkan cairan dan makanan yang sesuai keinginannya dan sesegera mungkin untuk mengosongkan kandung kemih , ajarkan juga tehnik relaksasi pernapasan yang efektif dan anjurkan untuk menghembuskan napas lebih lambat pada puncak kontraksi yang menyakitkan untuk mencegah dorongan.

Setelah bayi lahir, penting untuk menjaga komunikasi dengan ibu dan pendamping persalinan serta memberitahu tentang keadaan bayi. Tingkatkan kontak kulit-ke kulit dan letakkan bayi langsung diperut bagian atas ibu dan tutupi keduanya, pastikan kontak kulit ke kulit yang akan membantu merangsang pemberian ASI. Jaga keduanya tetap hangat beberapa jam setelah melahirkan. Penting juga menawarkan minuman dan makanan kepada ibu, karena kemungkinan ibu setelah bersalin akan mengalami dehidrasi.



Gambar 4.1 Posisi yang nyaman bagi ibu bersalin
Sumber : (WHO, 2013)

F. Berbicara dengan Ibu yang Menjalani Persalinan

Proses persalinan adalah hal yang menyenangkan bagi semua orang, keluarga dan teman-teman disekelilingnya. Dukungan dapat terlihat berbeda untuk setiap orang yang akan melahirkan. Fasilitasi ibu untuk mengkomunikasikan hal-hal yang dibutuhkan dan lakukan yang terbaik untuk memberikan kasih sayang dan menunjukkan perhatian.

G. Pengembangan Layanan Kesehatan

Kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan dinyatakan dengan perasaan puas jika pelayanan yang diberikan sesuai harapan pasien atau bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Strategi untuk meningkatkan layanan khususnya layanan pada ibu bersalin dapat dilakukan salah satunya dengan pengembangan layanan kesehatan. Strategi meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan

Pengembangan terhadap infrastruktur yang memadai, seperti ruang rawat inap pra dan paska bersalin. Ruangan yang ditata dengan baik, bersih membuat ibu merasa nyaman. Ketersediaan peralatan medis, dan fasilitas diagnostik yang memadai, sangat penting untuk memberikan pelayanan yang efektif. Investasi dalam teknologi canggih seperti MRI, CT scan, atau robot bedah dapat meningkatkan kualitas layanan.

2. Digitalisasi Sistem Kesehatan

Perkembangan teknologi dengan penggunaan Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Record/EMR) mendukung dalam layanan yang berkualitas. Penggunaan EMR dapat memberikan kemudahan dalam pencatatan riwayat kesehatan pasien, mempercepat diagnosis, dan mengurangi risiko kesalahan medis. Ibu hamil yang dalam proses bersalin dapat dengan cepat didiagnosis berdasarkan riwayat kesehatan sebelumnya yang dengan cepat didapatkan dengan EMR. Begitu juga dengan layanan konsultasi jarak jauh (Telemedicine) memungkinkan pasien mendapatkan perawatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Ibu yang akan proses bersalin dapat datang ke rumah sakit bila waktu bersalinnya sudah dekat, sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama di rumah sakit.

3. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Tim medis yang terampil adalah kunci keberhasilan layanan kesehatan. Melalui program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan partisipasi dalam seminar keilmuan dapat membantu staf medis dan perawatan untuk tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru. Penerapan ilmu berbasis riset atau penelitian terkait persalinan atau tindakan prosedural berbasis riset dapat meningkatkan mutu layanan pada ibu bersalin.

4. Inovasi dalam Layanan Pasien

Layanan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien, seperti dalam perawatan ibu bersalin. Peningkatan Pengalaman Pasien dengan

memperhatikan lingkungan rumah sakit yang nyaman, proses administrasi yang sederhana, dan komunikasi yang ramah dapat meningkatkan kepuasan pasien.

5. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Edukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat mengurangi beban penyakit di masyarakat. Membuka kelas prenatal bagi ibu hamil sebagai sarana untuk memberikan layanan kesehatan pada pasien untuk meningkatkan pengetahuan sebelum, selama dan sesudah hamil. Menyediakan program pilihan sesuai dengan kebutuhan ibu diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pada ibu menghadapi persalinannya.

H. Inovasi dalam Pengembangan Layanan Kesehatan

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan kepuasan pada ibu bersalin yaitu melalui langkah-langkah inovasi dalam Pengembangan Layanan Kesehatan.

1. Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

AI dapat digunakan untuk menganalisis data pasien, membantu dalam diagnosis penyakit, dan merancang rencana perawatan yang lebih efektif.

2. Wearable Technology

Alat kesehatan seperti smartwatch atau perangkat pemantau tekanan darah dapat membantu pasien memantau kondisi kesehatan mereka secara mandiri.

3. Robotika Medis

Robot dapat digunakan dalam operasi presisi tinggi atau sebagai asisten medis dalam pengelolaan pasien.

4. Aplikasi Mobile untuk Kesehatan

Aplikasi seperti platform booking dokter, reminder obat, atau konsultasi online memberikan kemudahan akses kepada pasien.

5. Kesehatan Berbasis Data (Big Data)

Analisis big data dapat membantu penyedia layanan kesehatan memahami pola penyakit, memprediksi wabah, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya.

Bab 5

Penutup

Melahirkan merupakan transisi besar dalam kehidupan seorang ibu. Kenangan dan pengalaman persalinan dan kelahiran tetap melekat pada seorang ibu sepanjang hidupnya, yang berarti bahwa dukungan dan perawatan yang diterimanya selama masa ini sangatlah penting. Tujuan keseluruhan dari merawat ibu selama persalinan dan kelahiran adalah untuk menciptakan pengalaman positif bagi ibu dan keluarga sambil menjaga kesehatan dan bayi mereka, mencegah komplikasi dan menanggapi keadaan darurat. Penting bagi ibu yang menjalani persalinan untuk menerima dukungan emosional mulai dari kehamilan, untuk mendapatkan kenyamanan. Menerapkan intervensi psikososial yang melibatkan sumber dukungan emosional yang penting merupakan strategi yang menjanjikan yang dapat mencegah timbulnya komplikasi yang tidak diinginkan. Meningkatnya kuantitas dukungan dapat berpotensi memengaruhi kesejahteraan psikologis ibu secara negative sehingga membangun hubungan yang baik antara keluarga dan petugas kesehatan.

Momen melahirkan membawa banyak perubahan dalam kehidupan ibu. Memperoleh dukungan sosial yang cukup dari pasangan dapat menjadi faktor prognosis yang signifikan bagi

ibu selama bersalin, karena hal ini memudahkan adaptasi dan pemenuhan peran social. Persalinan merupakan masa yang menegangkan bagi seorang ibu. Banyak ibu yang akan mengalami rasa senang, cemas, takut dan panik selama proses persalinan. Pada masa ini dukungan suami ternyata sangat berpengaruh pada kondisi psikologis ibu melahirkan. Suami yang memberikan dukungan melalui sentuhan langsung dan motivasi dapat merangsang kontraksi, sehingga mempercepat proses persalinan. Semakin tinggi dukungan suami, semakin rendah kecemasan menghadapi persalinan pada ibu hamil. Sebaliknya semakin rendah dukungan suami, semakin tinggi tekanan dalam menghadapi persalinan pada ibu hamil. Dukungan suami seperti dukungan emosional, penghargaan dan informatif dapat membantu ibu hamil merasa lebih siap menghadapi persalinan. Hal ini dapat menimbulkan rasa aman dan percaya diri karena merasa tidak berjuang sendirian dalam menghadapi persalinan (Heidi K, Wan Sulastri Emin, Yusrah Taqiyah, 2023).

Dalam persiapan menghadapi proses persalinan factor yang sangat penting adalah dukungan suami. Dukungan tersebut bagi ibu selama persalinan aktif dan kelahiran secara signifikan meningkatkan kepuasan keluarga terhadap pengalaman melahirkan, mengurangi penggunaan obat-obatan dan intervensi, serta meningkatkan sikap positif yang dibutuhkan perempuan dalam merawat bayinya (Gebuza at.al, 2016). Dukungan social selama persalinan dan kelahiran penting karena dapat membantu Wanita merasa aman secara emosional. Dukungan selama persalinan dan kelahiran yang diberikan

meliputi dukungan emosional, informasi tentang kemajuan persalinan, memberikan pijatan, pemberian minuman dan makanan ringan, memberi informasi terkini kepada anggota keluarga. Bentuk dukungan yang diberikan suami kepada isteri selama proses persalinan adalah mendampingi isteri saat persalinan. Dukungan keluarga merupakan bantuan yang dapat diperlukan selama persalinan. Dukungan ini untuk memotivasi, menghibur dan membantu ibu dalam melahirkan.

Dukungan suami dapat mempengaruhi kejiwaan ibu akan mempengaruhi kejiwaan ibu yang dampaknya terciptanya perasaan aman dan percaya diri, karena ibu tidak merasa berjuang sendirian, oleh karena itu dukungan suami yang tinggi membuat suasana proses persalinan ibu menjadi lebih baik dan ibu mampu mengelola stress yang dihadapinya (Selamita, dkk, 2022). Kepuasan ibu terhadap persalinan dipengaruhi oleh cara persalinan. Pengalaman melahirkan meninggalkan kesan pada ibu lebih dari satu decade setelah melahirkan.

Daftar Pustaka

- Bossano, C. M., Townsend, K. M., Walton, A., Blomquist, J. L., & Handa, W. L. (2017). Pengalaman persalinan ibu lebih dari satu dekade setelah melahirkan. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 217, 342.e1–342.e8. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.04.027>
- Christiaens, W., & Bracke, P. V. (2007). Assessment of social psychological determinants of satisfaction with childbirth in a cross-national perspective. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 7, 26.
- Counselling for Maternal and Newborn Health Care: A Handbook for Building Skills. (2013). Support during labour and childbirth. Geneva: World Health Organization. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304186/>
- Dekker, R. (2022). The evidence on: Birthing positions. Diakses dari <https://evidencebasedbirth.com/evidence-birthing-positions/>
- Desai, N. M., & Tsukerman, A. (2023). Persalinan normal. Dalam *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559197/>
- Edaso, A. U., & Teshome, G. S. (2019). Mothers' satisfaction with delivery services and associated factors at health institutions in West Arsi, Oromia regional state, Ethiopia. *MOJ Women's Health*, 8(1).
- Fikadu, T., Alemu, A., Beya, M. F., Gezahagn, A., Negash, E. S., & Getaye, A. N. (2023). Intrapartum care and associated birth in public hospitals. *Global Women's Health*, October, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2023.1203798>
- Gizew, A. D. (2018). Satisfaction of maternal care among women delivered at Asrade Zewude Memorial Primary Hospital, Bure, West Gojjam, Amhara, Ethiopia: A cross-sectional study. *Journal*

of Public Health and Epidemiology, 10(5), 147–154.
<https://doi.org/10.5897/JPHE2018.1013>

- Goodman, P., Mackey, M. C., & Takavoli, A. S. (2004). Factors related to childbirth satisfaction. *Journal of Advanced Nursing*, 46(2), 212–219.
- Heidi, K., Wan Sulastri Emin, Yusrah Taqiyah, W. O. S. A. (2023). Husband's support for the childbirth process: Concept analysis. *Idea Nursing Journal*, 2(02), 87–91.
- Hendriani, C. (2006). Analisis harapan dan kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan persalinan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Hijazi, H. H., Alyahya, M. S., Al Abdi, R. M., Alolayyan, M. N., Sindiani, A. M., Raffee, L. A., Baniissa, W. A., & Al Marzouqi, A. M. (2021). The impact of perceived social support during pregnancy on postpartum infant-focused anxieties: A prospective cohort study of mothers in Northern Jordan. *International Journal of Women's Health*, 13, 973–989.
<https://doi.org/10.2147/IJWH.S329487>
- International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. (2018). Article 2547. Volume 7(7).
<https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20182859>
- Jameei-Moghaddam, M., & Mirghafourvand, M. (2022). The relationship between women's satisfaction with personnel's support during labor, fear of childbirth, and duration of labor stages. *Semj*, 23(7). <https://doi.org/10.5812/semj.119086>
- Kemenkes RI. (2014). Info Datin: Status Kesehatan Ibu. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*.
- Kurniawati, D. (2015). Hubungan antara kondisi psikososial ibu pada masa postpartum dan kepuasan ibu terhadap pelayanan persalinan dengan ikatan antara ibu dan bayi. Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20415612&lokasi=lokal>

- López-Zeno, L. A., & Harrington, L. (2004). Normal labor and delivery. Dalam J. J. Sciarra (Ed.), *Gynecology & obstetrics* (Vol. 2, Bab 68). Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins. Diakses dari <http://www.glowm.com/resources/glowm/cd/pages/v2/v2c068.html>
- Lowe, N., Perrin, A. N., & Tanglakmankhong, K. (2010). Childbirth self-efficacy inventory and childbirth attitudes questionnaire: Psychometric properties of Thai language versions. *Journal of Advanced Nursing*.
- Maharani, T. I., & Fakhurrozi, M. (2014). Hubungan dukungan sosial dan kecemasan dalam menghadapi persalinan pada ibu hamil trimester ketiga. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2.
- Mane, U. R., Salunkhe, J. A., & Kakade, S. (2024). Family support to women during pregnancy and its impact on maternal and fetal outcomes. *Cureus*, 16(6), e62002. <https://doi.org/10.7759/cureus.62002>
- Manurung, S., & Dinarty. (2009). Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas merek pada pengguna kartu prabayar Simpati. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mattison, C. A., Dion, M. L., Lavis, J. N., Hutton, E. K., & Wilson, M. G. (2018). Midwifery and obstetrics: Factors influencing mothers' satisfaction with the birth experience. *Birth*, 45(3), 322–327. <https://doi.org/10.1111/birt.12352>
- Okonofua, F., et al. (2017). Qualitative assessment of women's satisfaction with maternal health care in referral hospitals in Nigeria. *Reproductive Health*, 14(44). <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0305-6>
- Patil, R., & Ayadi, A. M. E. (2024). The role of social support in the decision to migrate for childbirth: Qualitative evidence from India. <https://www.researchsquare.com/article/rs-4839396/v1>
- Ramie, dkk. (2014). Kontrol diri dan efikasi diri meningkatkan kepuasan ibu menjalani proses persalinan. *Jurnal Ners*, 9(1), 97–103.

- Sayed, W., Abd ElAal, D. E. M., Mohammed, H. S., Abbas, A. M., & Zahran, K. M. (2016). Maternal satisfaction with delivery services at tertiary university hospital in Upper Egypt: Is it actually satisfying?
- SDKI. (2017). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jakarta: BKKBN, BPS, Kementerian Kesehatan RI.
- Selamita, dkk. (2022). Hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan pada ibu bersalin. *Jurnal*, 1(8), 9–18.
- Srivastava, A., Avan, B. I., Rajbangshi, P., & Bhattacharyya, S. (2015). Determinants of women's satisfaction with maternal health care: A review of literature from developing countries. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-015-0525-0>
- Tesfaye, R., Worku, A., Godana, W., & Lindtjorn, B. (2016). Client satisfaction with delivery care service and associated factors in the public health facilities of Gamo Gofa zone, Southwest Ethiopia: In a resource-limited setting. *Obstetrics and Gynecology International*, 2016(5798068). <https://doi.org/10.1155/2016/5798068>
- UNICEF. (2017). Laporan PBB: Kematian ibu dan anak.
- Visvalingam, A., Dhillon, J. S., Gunasekaran, S. S., & Nasional, U. T. (2019). Role of social support in self-management of health. <https://doi.org/10.22059/jitm.2019.73268>
- Volkert, A., Bach, L., Hagenbeck, C., Kössendrup, J., Oberrohrmann, C., Okumu, M. R., & Scholten, N. (2024). Obstetric interventions' effects on the birthing experience. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1), 508. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06626-5>
- Wang, Y., Gu, J., & Zhang, F. (2023). The effect of perceived social support on postpartum stress: The mediating roles of marital satisfaction and maternal postnatal attachment. *BMC Women's Health*, 23, 482. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02593-9>

- Weeks, F., Pantoja, L., Ortiz, J., Foster, J., Cavada, G., & Binfa, L. (2016). Labor and birth care satisfaction associated with medical interventions and accompaniment during labor among Chilean women. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 62(2), 196–203. <https://doi.org/10.1111/jmwh.12499>
- WHO. (2020). Maternal mortality. Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- WHO, UNICEF. (2012). Trends in maternal mortality and morbidity, 1990–2010. WHO, UNICEF, UNFPA, and The World Bank estimates.
- Zamani, P., et al. (2019). The correlation between perceived social support and childbirth experience in pregnant women. *Midwifery*.
- Zulala, & Herfanda. (2019). Harapan ibu terhadap asuhan sayang ibu oleh bidan selama proses persalinan. *Media Ilmu Kesehatan*, 8(2).

Profil Penulis



Ns. Ira Sukyati, S.Kep, M.Kep., Sp.Kep.Mat, lahir di Jakarta, 07 Februari 1980. Telah menyelesaikan Pendidikan Diploma III Keperawatan di Universitas MH. Thamri Jakarta Timur Pada Tahun 2001. Pendidikan sarjana keperawatan (2006) dan Magister Keperawatan (2017) dan Pendidikan Spesialis Keperawatan Maternitas (2018) di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang bekerja sebagai dosen keperawatan Maternitas di STIKes Pasar Rebo Jakarta. Penulis telah mengikuti berbagai workshop, seminar dan pelatihan sesuai bidang keilmuannya. Penulis dapat dihubungi melalui sukyatiira@gmail.com

Profil Penulis



Ns. Merida Simanjuntak, S.Kep., M.Kep., Sp.Mat

Lulus DIII Keperawatan di Akademi Perawatan PGI Cikini Jakarta tahun 1996. Bekerja sebagai perawat pelaksana dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002 di RS PGI Cikini Jakarta. Melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus tahun 2002 dan

kemudian lulus S2 Keperawatan spesialis Keperawatan Maternitas tahun 2009 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

Saat ini aktif sebagai dosen tetap di STIKES Pasar Rebo Jakarta. Mata kuliah yang diampu adalah keperawatan Maternitas, Konsep Dasar Keperawatan dan Metodologi Keperawatan. Sebagai salah satu anggota TIM POKJA DPP PPNI yang sudah menyusun buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan yang terbaru adalah Standar Prosedur Operasional (SPO) yang terbit tahun 2021 untuk digunakan perawat yang bekerja di layanan kesehatan dan juga bagi mahasiswa keperawatan.

E-mail: merida_juntak@yahoo.com

Profil Penulis



Ns. IGA Dewi Purnamawati, SKp, MKep, Sp.Kep.An. lahir di Bali, 16 Maret 1976. Telah menyelesaikan Pendidikan Diploma III Keperawatan di Universitas MH Tamrin Jakarta Timur pada tahun 1996. Pendidikan Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan dan Pendidikan Spesialis Keperawatan Anak di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Depok

pada Tahun 2014. Sejak tahun 2000 sampai saat ini sebagai Dosen pada Departemen Keperawatan Anak di STIKes Pasar Rebo Jakarta. Penulis telah mengikuti berbagai workshop, seminar dan pelatihan sesuai bidang keilmuannya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ig4dewi@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas mengenai pengaruh dukungan social khususnya suami terhadap tingkat kepuasan ibu dalam menghadapi proses persalinan, yang penting dan mendesak diangkat dalam pembahasan khusus dan mendalam seperti yang termuat dalam buku ini. mengarah pada bantuan emosional jika diperlukan, bantuan ini bisa didapatkan dari keluarga, tetangga, kolega, saudara dan tim medis berupa dukungan psikologis dan informatif kepada ibu. Ibu yang mendapatkan dukungan selama persalinan cenderung akan melahirkan secara spontan, tidak mengalami komplikasi persalinan dan merasa puas dengan pengalaman persalinannya. Oleh karena itu, dukungan social dalam meningkatkan kepuasan ibu menjalani proses persalinan perlu dieksplorasi secara mendalam, mengingat Proses ini bisa jadi hal yang membahagiakan karena menjadi ujung dari kehamilan. Persalinan juga sekaligus bisa menakutkan dan melelahkan karena prosesnya membutuhkan banyak kesabaran. Terlebih lagi, dampak yang terjadi jika ibu hamil sampai melahirkan kurang mendapatkan dukungan social yaitu kurang efektifnya proses menyusui dan rendahnya kecerdasan pada bayi serta depresi saat kehamilan dan pasca persalinan. Pesan pentingnya adalah bagaimana dukungan social bisa didapatkan sejak ibu hamil sampai melahirkan.

Buku ini membahas mengenai pengaruh dukungan social khususnya suami terhadap tingkat kepuasan ibu dalam menghadapi proses persalinan, yang penting dan mendesak diangkat dalam pembahasan khusus dan mendalam seperti yang termuat dalam buku ini. mengarah pada bantuan emosional jika diperlukan, bantuan ini bisa didapatkan dari keluarga, tetangga, kolega, saudara dan tim medis berupa dukungan psikologis dan informatif kepada ibu. Ibu yang mendapatkan dukungan selama persalinan cenderung akan melahirkan secara spontan, tidak mengalami komplikasi persalinan dan merasa puas dengan pengalaman persalinannya.

Oleh karena itu, dukungan social dalam meningkatkan kepuasan ibu menjalani proses persalinan perlu dieksplorasi secara mendalam, mengingat Proses ini bisa jadi hal yang membahagiakan karena menjadi ujung dari kehamilan.

Persalinan juga sekaligus bisa menakutkan dan melelahkan karena prosesnya membutuhkan banyak kesabaran. Terlebih lagi, dampak yang terjadi jika ibu hamil sampai melahirkan kurang mendapatkan dukungan social yaitu kurang efektifnya proses menyusui dan rendahnya kecerdasan pada bayi serta depresi saat kehamilan dan pasca persalinan. Pesan pentingnya adalah bagaimana dukungan social bisa didapatkan sejak ibu hamil sampai melahirkan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

ISBN 978-634-7097-84-2



9

786347

097842

